SDD 84 Sujet n°1

Spécialité : Dermatologique

Date : 27/09/2023
Auteur : RAVEL Anaïs (DES de Psychiatrie - ECN 2023)
Relecteur(s) :

- ELAYLI Robin (DES de psychiatrie - ECN 2023)
- HARDY Quentin (DES de Dermatologie - ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Iconographie
Domaine d'apprentissage secondaire	Communication inter-professionnelle
Item(s) en lien avec la station	ITEM 302 Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 84 Lésion cutanée
Matériel nécessaire à la station	- Photographie disponible avec le sujet - une feuille - Un stylo - 2 chaises - Une surface plate pour poser la photo et pour pouvoir écrire
Contexte de la station	Demande d'avis dermatologique sur la photo d'une lésion suspect

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes dermatologue et recevez un appel téléphonique du Dr T. concernant Monsieur M, 57 ans. Il vous a envoyé la photo du grain de beauté de l'épaule gauche qui l'inquiète.
Monsieur D. dit ne l'avoir jamais remarqué avant aujourd'hui, sachant qu'il s'inspecte une à deux fois par an de par sa tendance à prendre vite et fréquemment des coups de soleil. Il n'a aucun antécédent particulier et ne prend aucun traitement particulier.

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes /annoncer/prescrire :

- Analyser l'image de cette lésion cutanée
- Émettre une hypothèse diagnostique
- Expliquez le contexte du patient qui vous fait émettre cette hypothèse
- Dire à votre confrère ce qu'il doit communiquer au patient pour la prise en charge de ce grain de beauté

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Rubrique 1 : Analyse sémiologique de l'iconographie			
1.	Mentionne une Asymétrie	1 pt	☐
2.	Mentionne des Bords Irréguliers	1 pt	☐
3.	Mentionne une couleur inhomogène	1 pt	☐
4.	Mentionne le diamètre > 6mm	1 pt	☐
5.	Mentionne l'évolution évoquant une apparition récente	1 pt	☐
Rubrique 2 : Hypothèse diagnostic			
6.	Évoque un mélanome	3 pt	☐
7.	Évoque le contexte du patient (Les 2 éléments suivant doivent être cités) : - Phototype clair - Contexte de "coups de soleil" OU brûlures cutanées de 1er degré photo-induite OU d'exposition solaire importante	2 pt	☐
Rubrique 3 : Prise en charge			
8.	Oriente vers un dermatologue	1 pt	☐
9.	Préciser que le rendez-vous doit être pris rapidement (dans les semaine à venir	0,5 pt	☐
10.	Dit qu'il y aura une exérèse à visée diagnostique	2 pt	☐
11.	Dit que l'exérèse de la lésion sera complète	1 pt	☐
12.	Dit que l'exérèse se fait sous anesthésie locale	0,5 pt	☐
13.	Dit qu'une reprise chirurgicale est possible (si les marges ne sont pas saines)	0,5 pt	☐
14.	Dit qu'il y aura une analyse anatomo-pathologique OU histologique de l'exérèse	1 pt	☐
15.	Dit qu'un bilan d'extension sera à prévoir selon les résultats de l'anatomopathologie	0,5 pt	☐

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			
1.	**6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

2.	**7. APTITUDE À COOPÉRER avec les pairs**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Autoritaire / Difficulté à coopérer	Communique. Transmet l'information	Communique. Adopte la technique de reformulation.	Communique les renseignements pertinents. Reconnaît les obstacles à la communication. Délègue les responsabilités en respectant les autres.	Reconnaît les problèmes de communication et sait les régler avec adresse.

3.	**12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	**… / 20 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

- Le terme “Coup de soleil” est considéré comme acceptable dans la communication avec les pairs, bien qu’il ne soit pas très médical. En effet, le terme “Brûlure au 1er degré photo-induite” n’est pas vraiment un terme utilisé par le milieu médical.
- L’aspect de communication inter-professionnelle nécessite que vous utilisiez les termes :
  - Exérèse (et pas dire “on va enlever la lésion”)
  - Naevus (ne pas dire “grain de beauté”)
  - Phototype clair (et non pas “peau blanche/clair)
- Un élément important que le médecin devra dire au patient et que l’exérèse est DIAGNOSTIQUE, et non pas pour guérir.

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Les candidats.es sont dermatologue et reçoivent un coup de téléphone de votre part. Vous êtes le médecin traitant de Mr.M et appelé après avoir envoyé une photo par mail d'un "grain de beauté" suspect qui vous inquiète.
Monsieur D. dit ne l'avoir jamais remarqué avant aujourd'hui, sachant qu'il s'inspecte une à deux fois par an de par sa tendance à prendre vite et fréquemment des coups de soleil. Il n'a aucun antécédent particulier et ne prend aucun traitement particulier.

Plan de la station ECOS :

Vous serez face à l'étudiant.e, sans qu'il n'y ait besoin d'un contact visuel de part la nature téléphonique de votre échange

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

« Voilà, donc maintenant pourriez vous me dire ce que vous pensez de cette photo. Je ne sais pas trop quoi en penser, j'aimerais avoir votre avis. »

Identité du patient :

- Monsieur D. Jean-marie, Homme
- 57 ans, 1m72, 62 kg

Mode de vie :

- Mariée, 3 enfants, aucun d'entre eux n'a de soucis de santé.
- Ouvrier, travail en extérieur sur des chantiers

- Ancien fumeur à 16 Paquet année, Alcool occasionnel

Comportement global :

En tant que médecin, vous devez avoir :
- Comportement solennel, respectueux
- Langage soutenu

Antécédents personnels :

Pas d'antécédent personnel (notamment pas de cancer ou de mélanome)

Antécédents familiaux :

Pas d'antécédent familiaux (notamment pas de cancer ou de mélanome)

Médicaments :

Pas de traitement de fond

Symptômes positifs :

<u>Concernant la lésion</u> :
- Si demande quand cette lésion a été mise en évidence : "C'est la première fois que le patient présente ce naevus. Elle est apparue au cours des 6 derniers mois selon lui"
- Si demande si la lésion est différente des autres grain de beauté/naevus : " Cette lésion dénote par rapport aux autres naevus du patient"
- Si demande si d'autres naevus sont suspect : " je l'ai examiné en entier pour le coup avec son accord, les autres naevus ne sont pas inquiétant et de morphologie normale"
- Si demande la taille : "Il fait environ 8 mm"
- Si demande si le patient présente d'autres symptômes : " Non il n'a pas d'autres symptômes"

Concernant le patient :
- Si demande le phototype du patient : "Il est de phototype 2"
- Si demande si le patient à souvent des coups de soleil/ des brûlures cutanée photo-induite : "Oui de par sa grande exposition solaire c'est assez fréquent chez lui les coups de soleil"

Donnée complémentaire :

Photographie disponible dès le début de l'épreuve

Questions de relance :

- En cas de moment de blanc dans la conversation après que les candidats.es est posé le diagnostique : « Qu'est-ce que je dois dire à mon patient ? »
- Si le candidat vous donne un diagnostique sans préciser son raisonnement (ne parle pas des caractéristiques de la photo ET du contexte du patient) : "D'accord, qu'est ce qui vous fait penser à cela ?"
- Si le candidat oriente vers un dermatologue sans précision sur ce que fera le dermatologue : "Que fera le dermatologue ?"

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Candidat.e et acteur.trice face à face, sans obligation de contact visuel de part la nature téléphonique de l'échange

Matériel nécessaire à la station :

- *Une feuille pour les candidats.es*
- *Un stylo pour les candidats.es*
- *La photographie disponible*
- *Une feuille pour l'examinateur.trice*
- *Un stylo pour l'examinateur.trice*

Documents présents dans la station :

- *Photographie de la lésion disponible avec le sujet*